Bài 37 CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN

Trần Hiếu Học
Quách Văn Kiên

zalo nhóm 0528112107

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được chẩn đoán xác định hội chứng chảy máu trong ổ bụng do nguyên nhân chấn thương tạng đặc.

2. Trình bày được chẩn đoán xác định hội chứng viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng.

3. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị chấn thương tạng đặc.

4. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị chấn thương tạng rỗng.

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Chấn thương bụng là những chấn thương gây tổn thương từ thành bụng đến các tạng trong ổ bụng nhưng không làm ổ bụng thông với môi trường bên ngoài.

Đây là cấp cứu ngoại khoa thường gặp, chiếm 10-13% tổng số mổ cấp cứu do nguyên nhân chấn thương nói chung, thường liên quan tới tai nạn giao thông, lao động và sinh hoạt.

Cơ chế chấn thương: Có thể do va đập trực tiếp như bị đấm, bị đá… gây tổn thương tạng khu trú nơi bị lực tác động trực tiếp, hoặc có thể do bị đè ép như bị sập nhà, xe đè qua bụng với tổn thương nặng và phức tạp. Cơ chế giằng xé do gia tốc lớn sau di chuyển tốc độ cao: Tai nạn xe đường cao tốc, ngã cao... thường gây nhiều tổn thương phối hợp và nặng.

Chẩn đoán chấn thương bụng chủ yếu dựa vào biểu hiện lâm sàng và các thăm dò cận lâm sàng. Do đặc điểm lâm sàng rất đa dạng, phức tạp nên chẩn đoán và xử trí các tổn thương trong ổ bụng hiện còn rất nhiều khó khăn. Tỉ lệ tử vong trung bình là 10%. Đối với bệnh nhân đa chấn thương, tỉ lệ này có thể lên tới 25%.

Chấn thương bụng có thể đi kèm các tổn thương khác như chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gẫy xương, ... nên cần thăm khám toàn diện để tránh bỏ sót tổn thương trong chẩn đoán và xử trí phẫu thuật.

Trong thực hành cấp cứu chấn thương bụng cần xác định được những chỉ định điều trị phẫu thuật. Nhiều khi phải thăm khám bệnh nhân nhiều lần, theo dõi chặt chẽ mới có được chỉ định điều trị phẫu thuật chính xác.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2. Giải phẫu bệnh

2.1. Thành bụng

Nhẹ là bầm tím, xây xát da, sưng nề do đụng dập, nặng hơn là tụ máu thành bụng, tổn thương các cơ thành bụng gây nguy cơ sa lồi thành bụng sau chấn thương.

2.2. Các tạng trong ổ bụng

- Tạng đặc: Các mức độ tổn thương từ nhẹ đến nặng là rạn, nứt, vỡ, dập. Có hai hình thái lâm sàng do tổn thương tạng đặc:

+ Chảy máu ngập ổ bụng có thể ào ạt dữ dội hay từ từ tùy theo mức độ vỡ.

+ Nếu dập vỡ nhu mô nhưng bao của tạng không rách sẽ gây tụ máu dưới bao hoặc tụ máu trong nhu mô và khối máu tụ có thể vỡ vào ổ bụng gây chảy máu thì 2.

Đồng thời, có thể kèm theo tổn thương cuống mạch (gây chảy máu trong ổ bụng) hoặc đường bài xuất của tạng đó như đường mật, ống tụy, đài bể thận (gây viêm phúc mạc).



A B

Hình 1. Vỡ gan, chảy máu trong ổ bụng

- Tạng rỗng: Các tạng rỗng có thể bị thủng, vỡ thậm chí bị đứt đoạn gây viêm phúc mạc nhưng cũng có khi bị dập vỡ không hoàn toàn, một vài ngày sau chỗ đụng dập bị hoại tử gây viêm phúc mạc do thủng thứ phát hoặc được các tạng bao bọc tạo thành khối dính, ổ áp xe.

- Mạc treo, mạc nối, mạch máu: Có thể bị đụng dập, máu tụ hoặc bị đứt, rách và gây thiếu máu phần tạng tương ứng. Cơ hoành có thể bị rách, vỡ gây thoát vị hoành.

II. CHẨN ĐOÁN

Tổn thương các tạng trong chấn thương bụng có thể là tạng đặc hoặc tạng rỗng, gây ra hai hội chứng tương ứng: Hội chứng chảy máu trong ổ bụng và hội chứng viêm phúc mạc. Đứng trước một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, cần phải tiến hành xác định một số yếu tố liên quan đến chấn thương thông qua hỏi bệnh:

- Hỏi nguyên nhân chấn thương (do va đập hay do đè ép) để dự đoán nguy cơ tạng nào bị tổn thương, thời gian xảy ra tai nạn.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Tiền sử bệnh lý: Những tạng đặc có kích thước to hơn bình thường, đang có thương tổn bệnh lý (tạng có khối u, thận có sỏi…) thì nguy cơ dễ vỡ hơn.

- Bệnh nhân mới ăn hoặc có tình trạng bàng quang căng trước khi bị chấn thương thì rất dễ bị vỡ, khi ở tình trạng xẹp tạng rỗng sẽ ít bị tổn thương hơn.

1. Hội chứng chảy máu trong ổ bụng

1.1. Triệu chứng lâm sàng

- Triệu chứng cơ năng:

+ Đau bụng: Thường đau liên tục, lúc đầu đau tại vị trí tạng tổn thương, sau lan ra khắp bụng, đau tăng dần.

+ Dấu hiệu liệt ruột: Nôn hoặc buồn nôn, bí trung đại tiện thường xuất hiện muộn sau tai nạn.

+ Khó thở: Có thể thấy do đau, do bụng trướng, do mất máu.

- Toàn thân: Thường có tình trạng sốc với mức độ khác nhau tùy theo lượng máu chảy vào ổ bụng. Biểu hiện là mạch nhanh, huyết áp hạ, da xanh, niêm mạc nhợt, bệnh nhân hốt hoảng, lo âu, vã mồ hôi.

- Triệu chứng thực thể:

+ Nhìn: Tìm các vết xây xát, bầm tím trên da bụng, quan sát sự di động của thành bụng.

+ Bụng trướng đều và toàn bộ, từ từ tăng dần, mức độ nhiều ít tùy thuộc lượng máu trong ổ bụng và thời gian tiến triển.

+ Cảm ứng phúc mạc hoặc phản ứng thành bụng: Là dấu hiệu rõ nhất trong hội chứng chảy máu trong ổ bụng, vị trí rõ nhất ở vùng tương ứng tạng bị tổn thương.

+ Gõ đục vùng thấp.

+ Có thể sờ thấy một khối căng đau ở mạng sườn, to dần lên (chấn thương thận).

+ Thăm âm đạo - trực tràng: Túi cùng Douglas phồng, đau.

- Thăm khám toàn diện các bộ phận khác để phát hiện những tổn thương phối hợp (sọ não, cột sống, lồng ngực, xương chậu, chi…).

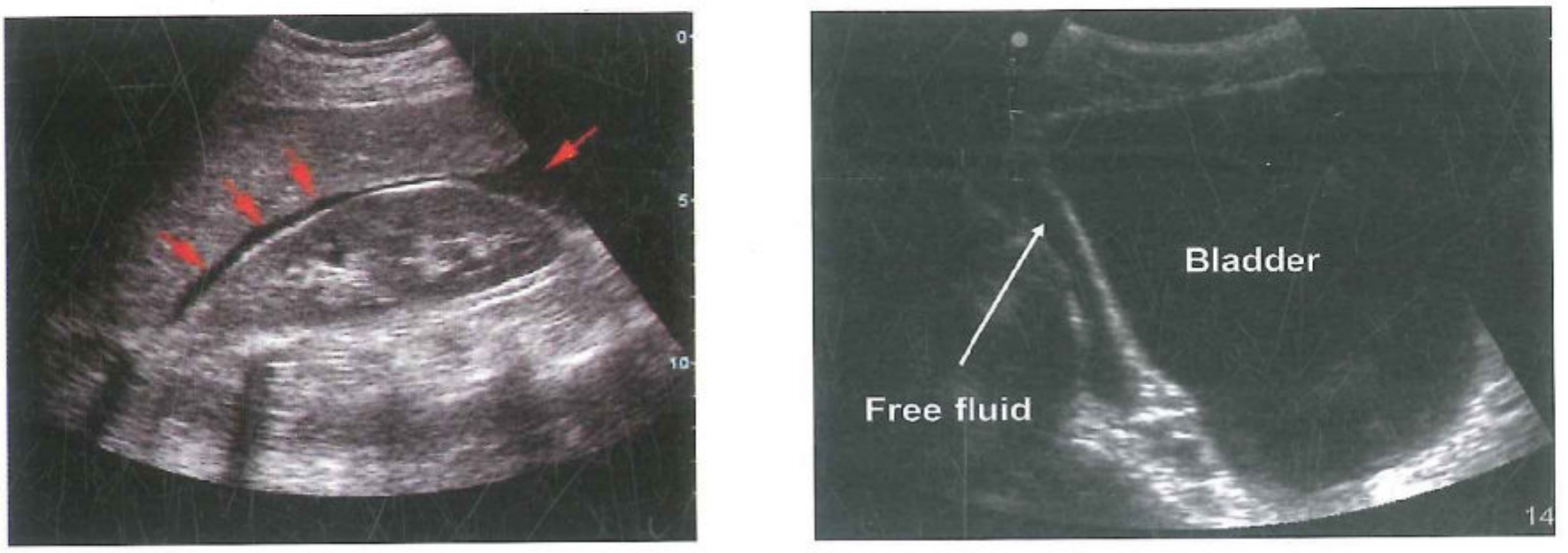
1.2. Cận lâm sàng

- *Xét nghiệm máu*: Hồng cầu giảm, huyết sắc tố giảm, hematocrit giảm, mức độ giảm nhiều hay ít tùy lượng máu chảy trong ổ bụng.

- *Siêu âm*: Là một thăm dò không xâm lấn, không nguy hiểm cho bệnh nhân, dễ thực hiện, dễ phổ cập và giá trị chẩn đoán cao, hơn nữa có thể làm đi làm lại nhiều lần và có thể thực hiện ngay tại giường kể cả khi bệnh nhân có huyết động không ổn định. Siêu âm không những cho ta thấy dấu hiệu có dịch trong bụng mà còn có thể thấy hình tổn thương tạng, thấy đường vỡ, thấy khối máu tụ. Siêu âm khó phát hiện được tổn thương tạng rỗng và cũng khó xác định tổn thương tụy.

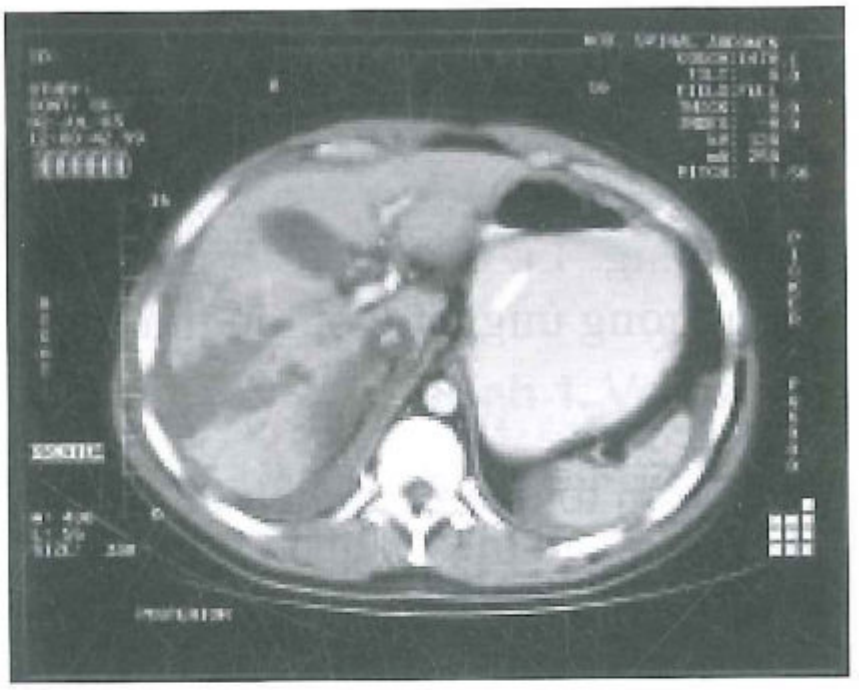
zalo nhóm duy nhất 0528112107

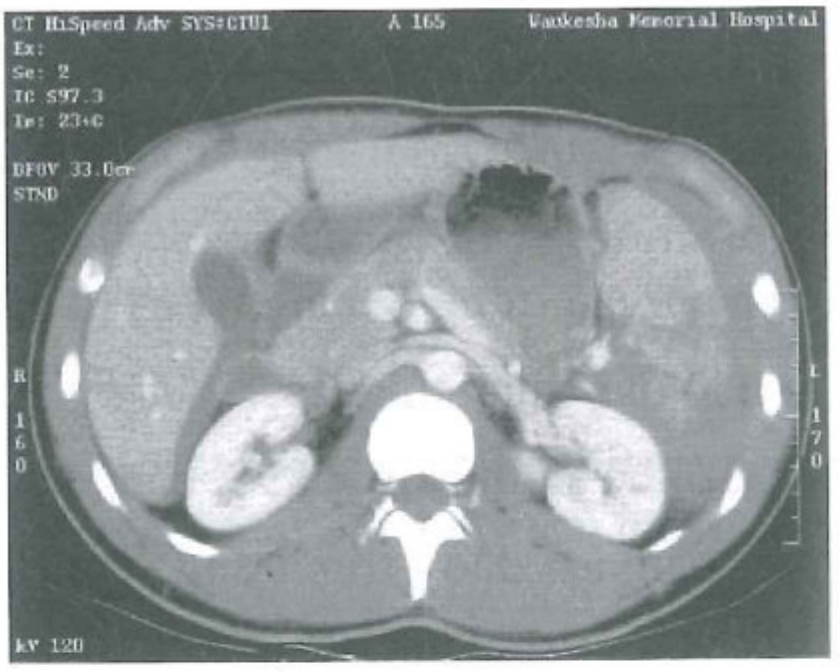
Tuy nhiên siêu âm cũng có những hạn chế: Khi thành bụng dày nhiều mỡ, khi các quai ruột giãn do trướng hơi nhiều và phụ thuộc vào kinh nghiệm của người làm siêu âm. Hiện nay sử dụng siêu âm có trọng điểm trong chấn thương (FAST - Focused Assessment with Sonography for Trauma) giúp phát hiện nhanh, sớm dịch trong ổ bụng và dịch màng ngoài tim qua khảo sát bốn vùng: Dưới mũi ức (tìm dịch màng tim), dưới sườn phải (dịch khoang gan thận), dưới sườn trái (dịch quanh lách) và trên xương mu (dịch Douglas) (Hình 2). Ngoài ra có thể thực hiện siêu âm có trọng điểm mở rộng (eFAST-exteded FAST) để đánh giá thêm tình trạng tràn máu và tràn khí màng phổi.



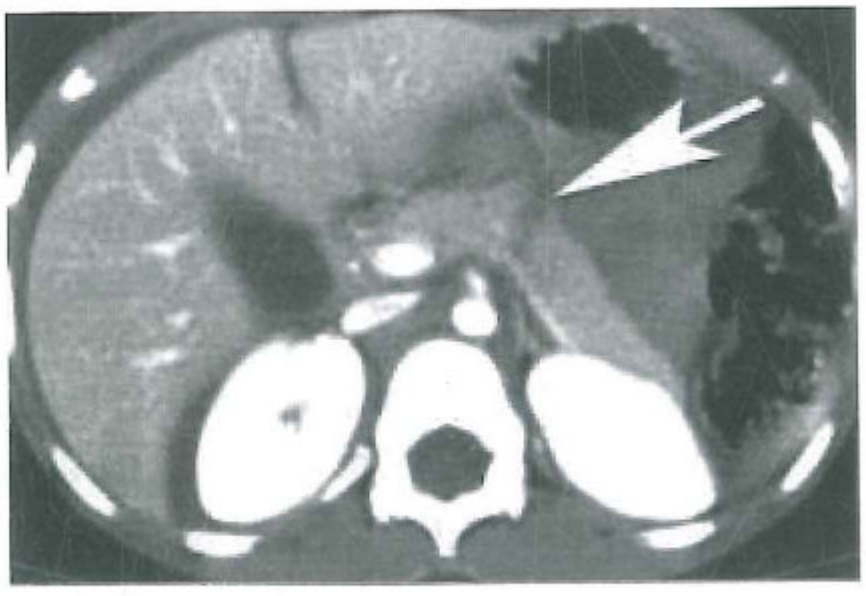
Hình 2. Hình ảnh dịch ổ bụng trên siêu âm

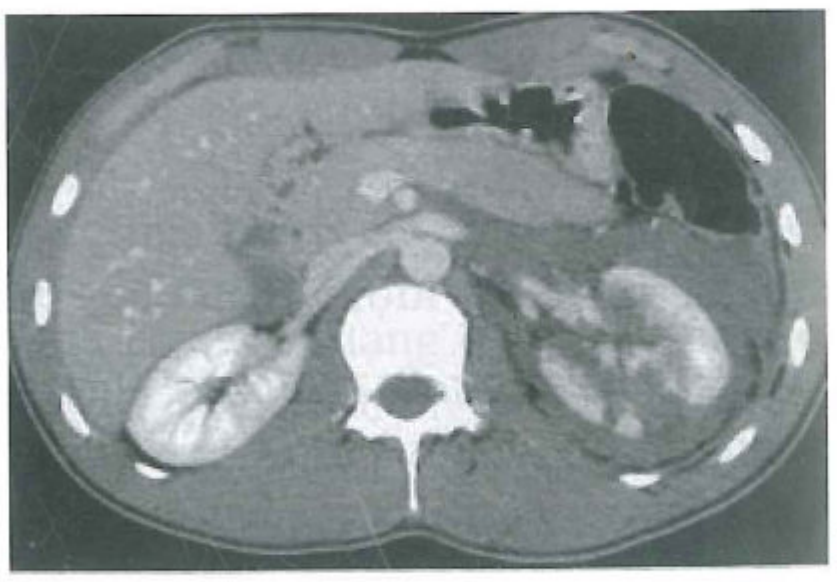
A. Khoang gan thận (Morrison); B. Túi cùng Douglas


A



B


C


D

Hình 3. Chụp CLVT ổ bụng: A. vỡ gan; B. Vỡ lách; C. Vỡ tuy; D. Vỡ thận

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- *X quang bụng không chuẩn bị*: Có thể thấy ổ bụng mờ, thành ruột dầy, các quai ruột giãn hơi, hình ảnh vỡ cơ hoành, tổn thương cột sống, khoang màng phổi. Chỉ chụp X quang bụng khi huyết động ổn định. Ngày nay X quang bụng ít được sử dụng vì giá trị chẩn đoán không cao mà muốn thực hiện phải vận chuyển bệnh nhân, thường phải chụp ở tư thế đứng, có thể gây nguy hiểm thêm cho bệnh nhân.

- Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ổ bụng:

Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch là phương pháp có giá trị nhất trong chẩn đoán hội chứng chảy máu trong ổ bụng. Phương pháp này giúp xác định chính xác tổn thương nhu mô, các đường vỡ tạng đặc (Hình 3), khối tụ máu, hình ảnh chèn ép và có dịch trong bụng, ngoài ra khi vỡ cơ hoành có thể thấy rõ các tạng trên lồng ngực. Hiện nay, phân loại tổn thương tạng đặc (gan, lách, tụy, thận) vẫn được áp dụng theo Hiệp hội phẫu thuật chấn thương Hoa Kỳ năm 2018 (AAST). Dưới đây là các phân loại chấn thương tạng đặc:

Bảng 1: Phân loại mức độ tổn thương lách theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn chấn thương lách theo AAST
I	Tụ máu dưới bao không tiến triển, < 10% diện tích bề mặt Rách bao lách, sâu vào nhu mô < 1cm
II	Tụ máu dưới bao 10 - 50% diện tích bề mặt; Tụ máu trong nhu mô < 5cm đường kính Rách nhu mô sâu 1-3cm, nhưng không có tổn thương mạch máu
III	Tụ máu dưới bao > 50% diện tích hoặc đang tiến triển; Tụ máu trong nhu mô > 5cm đường kính Rách sâu vào nhu mô > 3cm hoặc có tổn thương mạch máu
IV	Tổn thương mạch lách đang chảy máu. Đứt rời một thùy lách hoặc mất tưới máu > 25% lách
V	Vỡ nát lách Tổn thương mạch vùng rốn lách gây thiếu máu toàn bộ lách.

Bảng 2: Phân loại mức độ tổn thương gan theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn chấn thương gan theo AAST
I	Tụ máu dưới bao < 10% diện tích bề mặt Đường vỡ sâu vào nhu mô < 1cm
II	Tụ máu dưới bao 10 - 50% diện tích bề mặt; Tụ máu trong nhu mô < 10 cm đường kính Rách nhu mô sâu 1-3cm và dài ≤ 10 cm
III	Tụ máu dưới bao > 50% diện tích bề mặt hoặc trong nhu mô. Rách sâu vào nhu mô > 3cm và dài > 10 cm Bất cứ tổn thương mạch gan hoặc gây chảy máu thành tia trong nhu mô.
IV	Tổn thương đụng dập nhu mô 25 - 75% 1 thùy gan. Chảy máu thành tia do tổn thương mạch trong nhu mô gan vào ổ bụng
V	Tổn thương đụng dập nhu mô > 75% 1 thùy gan. Tổn thương mạch gan bao gồm TM chủ dưới sau gan, TM trên gan, TM .

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Bảng 3: Phân loại mức độ tổn thương tụy theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn chấn thương tụy theo AAST
I	Đụng dập nhỏ không tổn thương ống tụy Đường vỡ bề mặt không tổn thương ống tụy
II	Đụng dập nhu mô nhiều nhưng không tổn thương ống tụy Đường vỡ sâu nhưng không tổn thương ống tụy
III	Đường vỡ đoạn thân, đuôi tuỵ, hoặc rách nhu mô có tổn thương ống tuỵ
IV	Đường vỡ vùng đầu tụy (bên phải của tĩnh mạch mạc treo tràng trên) hoặc rách nhu mô có liên quan đến bóng Vater.
V	Tổn thương phức tạp vùng đầu tuỵ (Có thể liên quan đến tổn thương phối hợp tá tràng đầu tuỵ).

Bảng 4: Phân loại mức độ tổn thương thận theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn chấn thương thận theo AAST
I	Đụng dập thận, và tụ máu dưới bao không lan rộng Không có đường vỡ vào nhu mô
II	Tụ máu quanh thận không tiến triển, khu trú trong bao quanh thận Đường rách nhu mô vỏ thận sâu < 1cm, không thoát nước tiểu ra ngoài thận
III	Đường rách nhu mô > 1cm vùng vỏ thận lan vào vùng tủy thận nhưng không tổn thương bể thận hay không thoát nước tiểu ra ngoài thận. Tổn thương mạch thận hoặc chảy máu thành tia trong bao quanh thận.
IV	Đường rách nhu mô lan vào bể thận gây thoát nước tiểu. Tổn thương tĩnh mạch và động mạch thận chảy máu thành tia trong bao quanh thận Nhồi máu thận một phần hoặc hoàn toàn do huyết khối mạch máu mà không có chảy máu thành tia.
V	Đứt cuống thận Thận đụng dập toàn bộ làm mất hình thái giải phẫu.

Trên chụp CLVT có tiêm thuốc cho phép đánh giá các tổn thương vẫn tiếp tục chảy máu hay đã ngừng chảy, thông tin này rất có giá trị trong việc chọn lựa phương pháp điều trị. Tuy nhiên, hạn chế của biện pháp thăm dò này là yêu cầu bệnh nhân phải trong tình trạng huyết động ổn định.

- *Chọc dò ổ bụng*: Là phương pháp xác định nhanh chảy máu trong ổ bụng, áp dụng khi lượng máu chảy nhiều ảnh hưởng đến tình trạng toàn thân.

Kỹ thuật: Dùng bơm kim tiêm chọc qua thành bụng ở hố chậu hai bên (vị trí gõ đục), nếu hút ra máu không đông chứng tỏ có chảy máu trong ổ bụng.

Chọc dò ổ bụng có độ âm tính giả cao, độ chính xác phụ thuộc vào lượng máu trong ổ bụng, khi dưới 500 ml thì chọc dò ổ bụng khó phát hiện. Vì vậy, không chẩn đoán sớm các thương tổn trong ổ bụng đặc biệt là trong vỡ tạng rỗng. Hơn nữa, sau khi chọc dò âm tính cũng không thể loại trừ có tổn thương tạng hay không và khi đó việc

zalo nhóm duy nhất 0528112107

thăm khám lâm sàng rất khó khăn vì không phân biệt được phản ứng thành bụng do tổn thương hay do chọc dò.

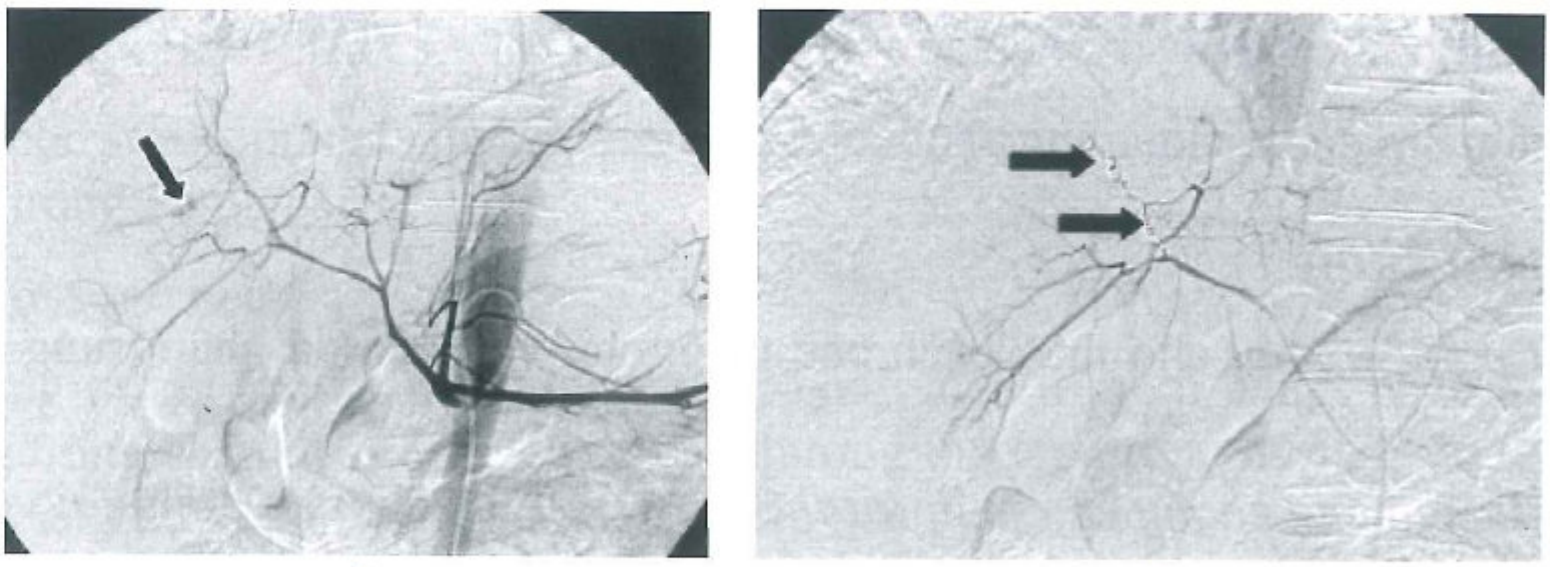
Chọc rửa ổ bụng: Dụng cụ chọc rửa gồm có một trocart nhỏ, đầu nhọn, có đường kính nòng 1,5 mm và một ống thông có kích thước lớn hơn đủ để luồn trocart, trên đầu ống thông có nhiều lỗ bên nhỏ và trên thân có những vạch đánh dấu chiều dài. Mở một lỗ nhỏ ở đường trắng giữa sát rốn, luồn ống thông vào ổ bụng, hướng về phía túi cùng Douglas, nếu không hút ra máu thì truyền qua ống thông 1000 ml dung dịch huyết thanh mặn đẳng trương, thay đổi tư thế bệnh nhân để dịch lưu thông đều trong ổ bụng sau đó đặt chai truyền xuống thấp, dịch tự chảy ra và nhận định kết quả:

+ Chọc rửa dương tính khi:
  - Hút được dịch máu hoặc dịch tiêu hóa qua ống thông.
  - Định lượng thấy hồng cầu > 100.000/mm^3, bạch cầu > 500/mm^3.
+ Chọc rửa âm tính khi:
  - Dịch rửa trong.
  - Dịch rửa có màu hồng, nhưng định lượng thấy hồng cầu < 50.000/mm^3, bạch cầu < 100/mm^3.
  - Trường hợp dịch rửa có màu hồng mà số lượng hồng cầu từ 50.000 - 100.000/mm^3 và lượng bạch cầu từ 100-500/mm^3 thì lưu ống thông và tiến hành rửa lại sau 2 giờ.

Chọc rửa ổ bụng có hiệu quả chẩn đoán tổn thương tạng với độ chính xác cao, nên cần được phổ biến và thực hiện rộng rãi trong cấp cứu chấn thương bụng, nhất là đa chấn thương.

- Chụp động mạch:

Đây là phương tiện chẩn đoán hình ảnh có xâm lấn, vừa có giá trị chẩn đoán, vừa có vai trò trong điều trị chảy máu. Kỹ thuật này thường được chỉ định trong trường hợp chảy máu do vỡ tạng đặc, vỡ khối u khi nghi ngờ có tổn thương chảy máu từ nhánh động mạch được phát hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang trước đó. Bệnh nhân sẽ được chụp chọn lọc động mạch thân tạng hoặc động mạch mạc treo tràng trên (Hình 4A), khi phát hiện ổ thoát thuốc có thể tiến hành nút động mạch bằng các vật liệu nút mạch để cầm máu tổn thương (Hình 4.B).



A B

Hình 4. Hình ảnh tổn thương nhánh của động mạch gan phải (mũi tên hình A) và sau nút mạch (mũi tên hình B)

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Nội soi ổ bụng:

Trước đây nội soi ổ bụng chỉ đơn thuần để chẩn đoán, nhưng hiện nay với phẫu thuật nội soi thì đây còn là một biện pháp có thể điều trị trong một số trường hợp. Nội soi ổ bụng chỉ định khi:

- Siêu âm nghi ngờ có tổn thương tạng.

- Có máu trong ổ bụng nhưng huyết động ổn định.

Tiến hành như một phẫu thuật: Phải gây mê nội khí quản, khi đưa ống soi vào quan sát nếu có nhiều máu, dịch phải hút sạch, nhân định tổn thương để quyết định bảo tồn hay phẫu thuật, có thể cầm máu bằng đốt điện hay khâu...

2. Hội chứng viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng

Mức độ thương tổn tạng rỗng chỉ được đánh giá trong mổ, các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ định hướng đến tạng bị tổn thương.

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Triệu chứng cơ năng:

+ Đau khắp bụng liên tục ngày càng tăng, bệnh nhân thường nằm im không dám thay đổi tư thế.

+ Nôn, bí trung đại tiện rõ.

- Toàn thân:

+ Hội chứng nhiễm trùng: Sốt 38-39^{0}C, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi.

+ Bệnh nhân đến muộn có thể thấy mạch nhanh, huyết áp giảm, đái ít, thở nhanh nông...

- Triệu chứng thực thể:

+ Bụng trướng đều toàn bộ, chủ yếu trướng hơi.

+ Gõ đục vùng thấp thể hiện trong ổ bụng có dịch và có thể thấy mất vùng đục trước gan (khi bụng trướng không nhiều thì mới có giá trị).

+ Có dấu hiệu phản ứng thành bụng, nhất là có co cứng thành bụng và có cảm ứng phúc mạc.

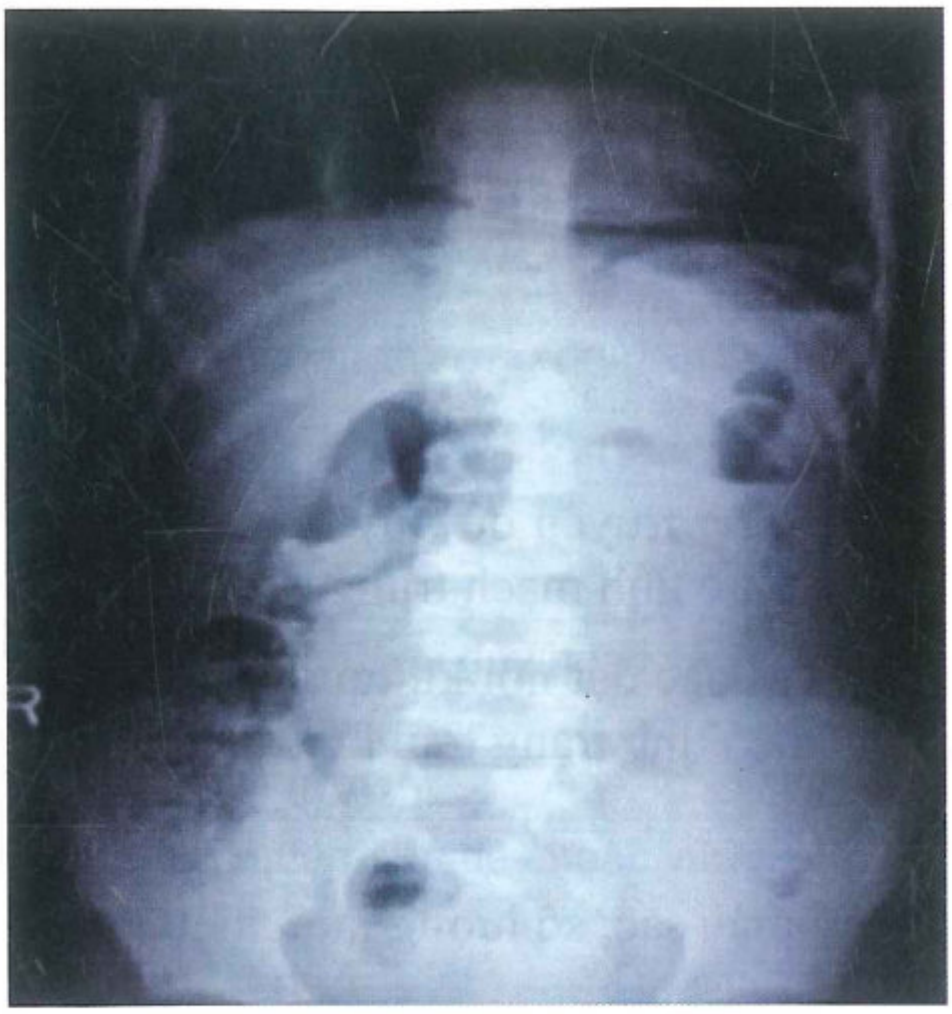
+ Thăm âm đạo - trực tràng: Túi cùng Douglas phồng, đau.

2.2. Cận lâm sàng

- *Xét nghiệm máu* cho thấy bạch cầu tăng, chủ yếu loại đa nhân trung tính, máu lắng tăng.

- *X quang bụng không chuẩn bị (tư thế đứng)*: Hình ảnh liềm hơi dưới vòm hoành gặp ở khoảng 80% các trường hợp (Hình 5), hình ảnh hơi sau phúc mạc trong trường hợp vỡ tá tràng, hình ảnh có dịch trong ổ bụng (ổ bụng mờ, thành ruột dày).

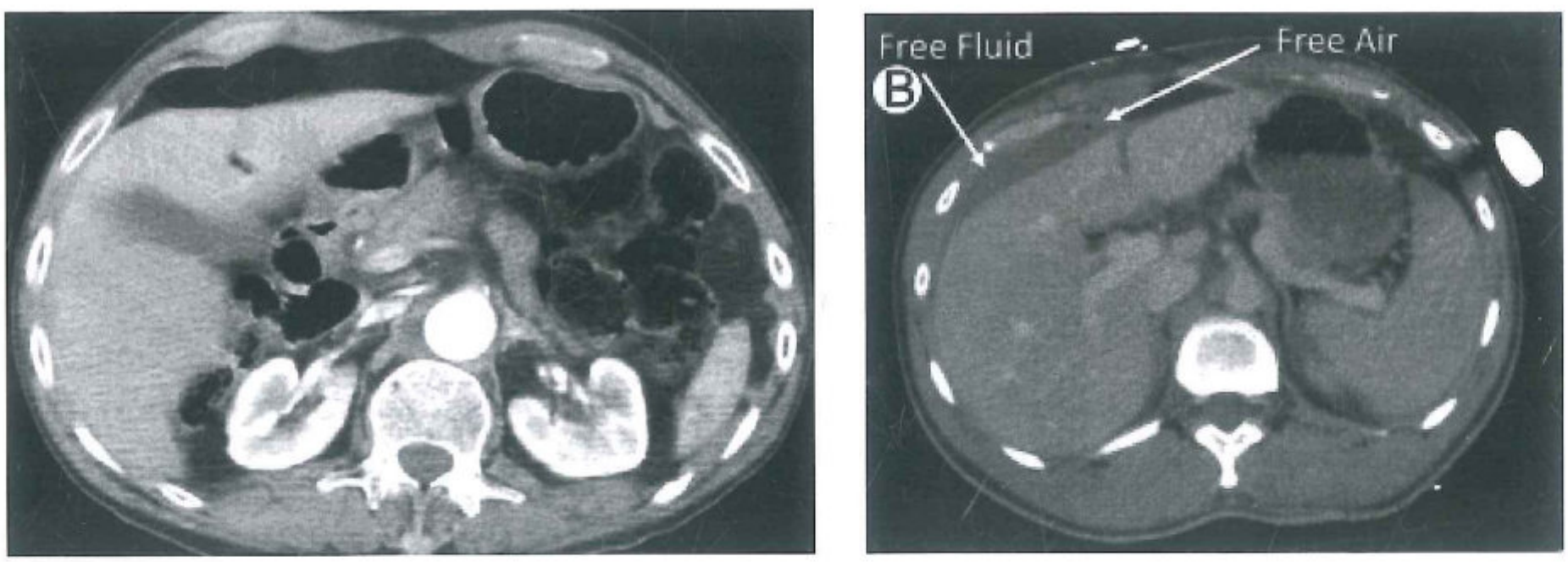
zalo nhóm duy nhất 0528112107



Hình 5. Hình ảnh liềm hơi dưới hoành hai bên

- *Siêu âm bụng:* Trong tổn thương tạng rỗng ít có giá trị hơn so với X quang. Hình ảnh thấy được là có dịch trong ổ bụng.

- *Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng*: Phát hiện được có khí, dịch trong ổ bụng, dày thành tạng bị tổn thương.



A B

Hình 6. Phim CLVT ổ bụng: Khí mặt trên gan (A) và dịch - khí (B)

- Chọc rửa ổ bụng: Hút ra dịch tiêu hóa hoặc xét nghiệm dịch rửa có trên 500 bạch cầu trong 1 ml.

- Nội soi ổ bụng:

Cũng tương tự như trong hội chứng chảy máu trong ổ bụng, phẫu thuật nội soi ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị các thương tổn tạng rỗng trong chấn thương bụng kín ngày càng được phổ biến. Bên cạnh việc xác định chẩn đoán, phẫu thuật nội soi có thể xử lý được những tổn thương không quá phức tạp của các tạng rỗng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

III. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị phẫu thuật

Chấn thương bụng là một cấp cứu trong ngoại khoa cần đồng thời hồi sức, xác định tổn thương và điều trị phẫu thuật.

1.1. Hồi sức cấp cứu

- Đặt một hoặc nhiều đường truyền để truyền máu và các chất thay thế máu dựa theo huyết áp động mạch và áp lực tĩnh mạch trung ương.

- Cho bệnh nhân thở oxy hoặc đặt nội khí quản và hô hấp hỗ trợ, nhưng phải chú ý dẫn lưu màng phổi trước nếu có tình trạng tràn khí, tràn máu màng phổi.

- Đặt ống thông dạ dày.

- Đặt thông đái theo dõi màu sắc, số lượng nước tiểu.

- Cho kháng sinh dự phòng.

- Trường hợp chảy máu trong nặng thì vừa mổ vừa hồi sức.

1.2. Chỉ định điều trị phẫu thuật

- Hội chứng chảy máu trong ổ bụng nặng (có sốc mất máu). Hiện nay, chụp cắt lớp vi tính bụng giúp chẩn đoán rõ mức độ tổn thương từng tạng đặc, từ đó có thể tiên lượng điều trị bảo tồn hay điều trị phẫu thuật.

- Hội chứng viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng.

1.3. Phẫu thuật

- Gây mê toàn thân có giãn cơ cho thành bụng mềm để có thể dễ dàng thăm dò và xử lý các tổn thương.

- Đường mổ: Đường mổ giữa trên và dưới rốn cho phép thăm dò toàn diện ổ bụng và khi cần có thể mở ngang. Trong trường hợp xác định chắc chắn tổn thương trước mổ có thể sử dụng đường mổ dưới sườn phải, như trong vỡ gan.

- Thăm dò ổ bụng:

+ Ngay khi vào ổ bụng cần xác định số lượng máu trong ổ bụng và vị trí chảy máu. Nếu chắc chắn chỉ có tổn thương gây chảy máu, không có tổn thương tạng rỗng, thời gian tai nạn dưới 6 tiếng thì có thể lấy máu truyền lại.

+ Cầm máu tạm thời bằng cách cặp các cuống mạch hoặc chèn gạc.

+ Xác định ngay các tổn thương chính, các thương tổn phối hợp, vị trí, hướng đi của tác nhân gây tổn thương.

+ Phải thăm dò toàn diện để đánh giá đầy đủ tổn thương trước khi xử trí. Trong trường hợp nghi ngờ có máu tụ sau phúc mạc, có hơi hoặc dịch mật xanh sau phúc mạc, phải bóc tách khối tá tụy hoặc mạc Told để phát hiện các tổn thương ở thành sau của tá tràng, đại tràng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

+ Chú ý các thương tổn ít gặp như vỡ cơ hoành, vỡ bàng quang ngoài phúc mạc…: Xử lý cụ thể tùy theo tổn thương từng tạng.

+ Dạ dày: Hầu hết các thương tổn đều có thể khâu đơn thuần sau khi làm sạch dạ dày. Cắt dạ dày khi đụng dập nặng và rộng, không bảo tồn được (độ III, IV, V).

Bảng 5: Phân độ chấn thương dạ dày theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn chấn thương dạ dày theo AAST
I	Đụng dập, tụ máu thành dạ dày Rách bán phần thành dạ dày
II	Rách < 2 cm chỗ nối thực quản - dạ dày hoặc vùng môn vị < 5 cm ở phần dạ dày 1/3 trên < 10 cm ở phần dạ dày 2/3 dưới
III	Rách > 2 cm chỗ nối thực quản - dạ dày hoặc vùng môn vị > 5 cm ở phần dạ dày 1/3 trên > 10 cm ở phần dạ dày 2/3 dưới
IV	Mất một phần thành dạ dày hoặc mất mạch < 2/3 dạ dày
V	Tổn thương mất thành dạ dày hoặc mất mạch > 2/3 dạ dày

+ Tá tràng: Lựa chọn phương pháp phẫu thuật tùy thuộc vào mức độ tổn thương tá tràng được đánh giá trong mổ: Lấy khối máu tụ thành tá tràng (độ I), khâu vết thương tá tràng đơn thuần hoặc kết hợp với các phẫu thuật bảo vệ như: Mở thông giảm áp (nối vị tràng, mở thông dạ dày, mở thông hỗng tràng, dẫn lưu túi mật); Loại trừ môn vị (phẫu thuật Jordan); Túi thừa hóa tá tràng; Patch quai ruột non vào diện tá tràng vỡ. Phẫu thuật cắt bỏ trong chấn thương tá tràng được áp dụng trong một số trường hợp, bao gồm: Cắt bỏ một phần tá tràng hoặc cắt khối tá tụy.

Bảng 6: Phân độ chấn thương tá tràng theo AAST 2018

Độ	Loại	Mức độ thương tổn chấn thương tá tràng theo AAST
I	Tụ máu	Trong một đoạn của tá tràng
	Rách	Rách một phần thành tá tràng, không thủng
II	Tụ máu	Hai đoạn của tá tràng trở lên
	Rách	Rách < 50% chu vi tá tràng
III	Rách	Rách 50%-75% chu vi của D2
		Rách 50%-100% chu vi của D1,D3,D4
IV	Rách	Rách > 75% chu vi của D2
		Tổn thương bóng Vater hoặc đoạn thấp của ống mật chủ
V	Rách	Đứt khối tá tràng đầu tụy phức tạp
	Mạch	Mất mạch nuôi tá tràng
*Tăng 01 độ cho những trường hợp nhiều tổn thương từ độ III trở xuống.		

+ Ruột non: Đối với các lỗ thủng nhỏ, gọn thì khâu đơn thuần còn với các tổn thương lớn hoặc nhiều tổn thương khu trú ở một đoạn thì cắt đoạn và nối lại.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Bảng 7: Phân độ chấn thương ruột non theo AAST 2018

Độ	Loại	Mức độ thương tổn ruột non do chấn thương theo AAST
I	Tụ máu	Tụ máu hoặc đụng dập, Còn tưới máu tốt
	Rách	Rách một phần thành ruột, không thủng
II	Rách	Rách < 50% chu vi ruột non
III	Rách	Rách > 50% chu vi ruột non nhưng chưa đứt rời
IV	Rách	Đứt đôi toàn bộ chu vi ruột non
V	Rách	Đứt rời 1 quai ruột non kèm mất mạch nuôi
	Mạch	Tổn thương mạch mạc treo gây thiếu máu 1 đoạn
*Tăng 01 độ cho những trường hợp nhiều tổn thương từ độ III trở xuống.		

+ Đại tràng: Về nguyên tắc không khâu kín đơn thuần mà phải kết hợp khâu vết thương và làm hậu môn nhân tạo phía thượng lưu hoặc đưa đoạn ruột bị tổn thương ra ngoài làm hậu môn nhân tạo rồi xử lý tiếp ở thì sau.

Bảng 8: Phân độ chấn thương đại tràng theo AAST 2018

Độ	Loại	Mức độ thương tổn chấn thương đại tràng theo AAST
I	Tụ máu	Tụ máu hoặc đụng dập, Còn tưới máu tốt
	Rách	Rách một phần thành ruột, không thủng
II	Rách	Rách < 50% chu vi đại tràng
III	Rách	Rách > 50% chu vi đại tràng nhưng chưa đứt rời
IV	Rách	Đứt đôi toàn bộ chu vi đại tràng
V	Rách	Đứt rời 1 quai đại tràng kèm mất mạch nuôi
	Mạch	Tổn thương mạch mạc treo gây thiếu máu 1 đoạn
*Tăng 01 độ cho những trường hợp nhiều tổn thương từ độ III trở xuống.		

+ Bàng quang: Dù vỡ trong hay ngoài phúc mạc thì cũng khâu và dẫn lưu bàng quang. Cắt bàng quang bán phần kết hợp với đặt JJ niệu quản hoặc cắm lại niệu quản được chỉ định với chấn thương bàng quang độ V.

Bảng 9: Phân độ chấn thương bàng quang theo AAST 2018

Độ	Loại	Mức độ thương tổn chấn thương bàng quang theo AAST
I	Tụ máu	Đụng dập, tụ máu trong cơ
	Rách	Rách bán phần thành bàng quang không thủng
II	Rách	Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc < 2cm
III	Rách	Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc ≥ 2cm hoặc trong phúc mạc < 2cm
IV	Rách	Vỡ bàng quang trong phúc mạc ≥ 2cm
V	Rách	Đường vỡ bàng quang trong hay ngoài phúc mạc lan đến cổ bàng quang hoặc gần lỗ niệu quản
*Tăng 01 độ cho những trường hợp nhiều tổn thương từ độ III trở xuống.		

zalo nhóm duy nhất 0528112107

+ Đường mật: Ít khi bị tổn thương, tuy nhiên nếu có thì cũng xử lý bằng cách khâu và dẫn lưu.

+ Gan: Tổn thương nhỏ có thể cầm máu bằng đốt điện hoặc khâu cầm máu gan, chú ý đường khâu phải tới đáy vết thương tránh để lại khoảng chết dẫn tới tụ máu sau khâu. Đối với những vết thương lớn không thể khâu tới đáy được thì có thể cầm máu diện vỡ và để ngỏ vết thương. Khi cầm máu khó khăn hoặc với vết thương ở vị trí khó khâu thì có thể dùng các chất xốp cầm máu (spongel) hoặc chèn gạc rồi rút dần sau 48 - 72 giờ. Có thể kết hợp thêm động tác thắt động mạch gan để làm giảm nguy cơ chảy máu. Nếu gan bị dập nát nhưng khu trú thì có thể tiến hành cắt gan từng phân thùy, hạ phân thùy tùy tổn thương (cắt gan điển hình) hoặc cắt tổn thương tới phần nhu mô lành để cầm máu (cắt gan không điển hình).

+ Lách: Có thể đốt điện, khâu cầm máu để bảo tồn lách giống như đối với gan hoặc có thể cắt một phần hay toàn bộ tùy mức độ tổn thương nhu mô lách. Cắt lách được chỉ định trong trường hợp đường vỡ lan vào cuống lách hoặc vỡ nát lách. Cắt lách cũng được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương, hoặc có bệnh ly về đông máu. Nếu phải cắt lách, sau mổ nên dùng thuốc chống vi khuẩn: vaccin chống não mô cầu… Cắt lách bán phần: Được chỉ định khi tổn thương ở một phía của lách, thường ở mặt sau hoặc mặt dưới lách.

+ Tụy: Nếu tụy bị đụng dập nhu mô nhẹ và không có tổn thương ống tụy thì chỉ cần cầm máu và đặt dẫn lưu cạnh vùng đụng dập. Với những tổn thương không bảo tồn được thì phải cắt tụy tùy theo vị trí tổn thương: Cắt khối tá - tuỵ với tổn thương đầu tuỵ, cắt đuôi tuỵ (có hoặc không kèm cắt lách) nếu thương tổn vùng đuôi, đóng đầu gần và nối đầu xa với ống tiêu hóa (dạ dày hoặc ruột) nếu tổn thương đứt đôi vùng thân tuỵ.

+ Thận: Những chỉ định tuyệt đối để thăm dò thận là đứt cuống thận, máu tụ to dần, huyết động không ổn định do những tổn thương ở thận. Đứt cuống thận (độ V) hoặc tổn thương mạch thận (độ IV, V) cần phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu, thường phải cắt thận. Trên thực tế, thành công của điều trị không mổ cho những trường hợp chấn thương độ III, IV đã cho thấy chỉ can thiệp ngoại khoa trong trường hợp chấn thương thận nặng, điều trị bảo tồn thất bại do chảy máu nhiều hoặc tiếp tục thoát nước tiểu mặc dù đã đặt stent niệu quản. Mổ thăm dò tổn thương thận có thể được phối hợp với mổ do chấn thương lách nặng hoặc tổn thương ruột non hay đại tràng.

2. Điều trị bảo tồn

Điều trị bảo tồn chỉ được chỉ định cho tổn thương tạng đặc, đặc biệt *chấn thương gan và chấn thương lách* với điều kiện tình trạng toàn thân ổn định, không có tổn thương đường bài xuất, tình trạng bụng không nhiều dịch và không đau tăng và hơn nữa phải ở cơ sở có phòng mổ.

Việc điều trị chủ yếu là bất động, có thể cho kháng sinh, nếu truyền dịch thì chỉ ở mức duy trì không làm tăng huyết áp và nhất là cần theo dõi sát. Nếu có dấu hiệu tiến triển không tốt như đau bụng tăng, mạch nhanh, huyết động không ổn định và thăm dò hình ảnh thấy dịch ổ bụng tăng lên thì phải xét đến khả năng phẫu thuật.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

2.1. Chấn thương tụy

Chỉ định điều trị bảo tồn trong chấn thương tụy trong các trường hợp được chẩn đoán chấn thương tụy độ I (50% trường hợp), II (23% trường hợp). Có hai cách điều trị bảo tồn:

- Đặt sonde dạ dày hút liên tục: Rất tốt vì sẽ tránh phải mở bụng thăm dò. Cần phải theo dõi sát (lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh) để loại trừ biến chứng.

- Dẫn lưu ngoài: Khi có ổ dịch quanh tụy do chấn thương gây ra triệu chứng. Tuy nhiên, nếu xuất hiện nang giả tụy, áp xe thì nguy cơ tổn thương ống tuỵ là rất cao. Có thể dẫn lưu dưới siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính. Thời gian lưu dẫn lưu là 7 - 10 ngày. Rút dẫn lưu khi nồng độ amylase dịch dẫn lưu thấp hơn amylase máu. Nếu sau 3 ngày mà amylase dịch dẫn lưu cao gấp 3 lần amylase máu chứng tỏ nguy cơ rò tuỵ cao.

2.2. Chấn thương thận

- Nhờ có sự đánh giá nhanh và chính xác của CLVT, kết hợp với tiến bộ của các phương pháp hồi sức, đã giảm được số trường hợp mổ thăm dò chấn thương thận. Hiện nay, chỉ ½ số trường hợp có vết thương thận và 5% trường hợp chấn thương thận phải điều trị bằng phẫu thuật.

- Tất cả trường hợp chấn thương thận độ I, II, không cần quan tâm đến cơ chế chấn thương, đều có thể điều trị bảo tồn bởi vì nguy cơ chảy máu thứ phát thấp.

- Hầu hết các thương tổn độ III, IV, kể cả trường hợp có mảnh rời và có thoát nước tiểu ra ngoài thận vẫn có thể điều trị bảo tồn nếu được theo dõi sát và kiểm soát huyết động tốt, có thể chụp phim lại kiểm tra. Nếu có chảy máu động mạch, có thể chụp mạch và nút mạch cấp cứu.

- Huyết khối động mạch thận hoặc các nhánh của nó cần can thiệp khi không có thận bên đối diện hoặc chấn thương, lúc đó phục hồi hay tái tạo mạch thận được chỉ định. Điều trị bằng đặt stent đang hứa hẹn nhưng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm.

3. Điều trị can thiệp mạch

Điều trị can thiệp mạch với mục đích cầm máu, vì vậy cũng chỉ định cho tổn thương tạng đặc khi tình trạng toàn thân cho phép. Dựa vào chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc thấy có thoát thuốc, sẽ sử dụng chụp mạch (kỹ thuật số hóa xoá nền) để xác định vị trí mạch tổn thương gây chảy máu rồi nút cầm máu bằng các vật liệu như spongel, PVA, keo Histoaryl, coil. Ưu điểm chính là thực hiện khá nhanh, gọn, cầm máu ngay, ít đau đớn, hồi phục nhanh và tránh được một phẫu thuật.

4. Theo dõi

- Với những trường hợp không có chỉ định điều trị phẫu thuật ngay (vỡ tạng đặc mức độ nhẹ) thì phải theo dõi chặt chẽ bằng lâm sàng (khám đi khám lại nhiều lần) và cận lâm sàng. Khi thấy các biểu hiện mất máu tăng dần thì phải điều trị phẫu thuật.

- Những trường hợp đụng dập nhu mô gây chảy máu nhưng bao của tạng không bị rách sẽ dẫn tới tụ máu dưới bao cần phải theo dõi nhiều ngày để phát hiện nguy cơ chảy máu thì hai do vỡ máu tụ.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Trường hợp đụng dập tạng rỗng nhưng chưa thủng hẳn cũng cần theo dõi vì có thể bị hoại tử chậm dẫn tới viêm phúc mạc trong những ngày sau.

IV. KẾT LUẬN

Chấn thương bụng kín là loại chấn thương thường gặp nhiều trong điều kiện nước ta hiện nay. Vấn đề quan trọng nhất trong chấn thương bụng là chẩn đoán để xác định trường hợp nào phải phẫu thuật và trường hợp nào không phải phẫu thuật. Tỷ lệ phải điều trị phẫu thuật không nhiều và có xu hướng giảm đi nhờ tiến bộ của điện quang ứng dụng trong chẩn đoán và can thiệp. Cần có thái độ xử trí nhanh chóng, thích hợp cho từng tình huống một cách hợp lý luôn là điều cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. T.B.Giang, N.N.Hùng, D.T.Hiền, N.Đ.Tiến, T.N.Dũng, L.N.Huy. (2004). Chỉ định và kết quả bước đầu điều trị không mổ chấn thương gan tại Bệnh viện Việt Đức 2004 - 2005.Tạp chí ngoại khoa. Tr 97 – 104
2. T.B.Giang, N.N.Hùng, L.N.Huy. (2011). Điều trị không mổ chấn thương gan tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 2006 – 2008. Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam. Tr 1635 – 1642.
3. Charles Brunicardi F., Dna K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Raphael E. Pollock. (2006). Trauma. Schwartzs manual of surgery, eighth edition, p. 97-137. *McGraw-Hill Companies, Medical Publishing Division, United States of America*,
4. Juan A. Asensio, and Donald D. Trunkey. (2008). Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. *Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.*
5. Judith E. Tintinalli, J. Stephan Stapczynski, David M. Cline, O. John Ma, Rita K. Cydulka, and Garth D. Meckler. (2011). Abdominal trauma. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, seventh edition. *The McGraw-Hill Companies, Inc, China,*
6. Moshe Schein, Paul N. Rogers. (2005). Blunt Abdominal Trauma. Scheins Common Sense Emergency Abdominal Surgery, Second edition. *Springer-Verlag Berlin Heidelberg,*
7. Morris, Peter J.; Wood, William C. (2000). The abdomen section. Oxford Textbook of Surgery, 2nd edition. *Oxford University Press.*
8. Peter F. Mahoney, James M. Ryan, Adam J. (2005). Brooks and William Schwab C. Abdomen and pelvis. Ballistic Trauma: A practical guide, Second Edition. *SpringerVerlag London Limited.*
9. Sabiston, David C., Townsend, Courtney M. (2012). Management of acute trauma. Townsend: Sabiston Textbook of Surgery, 19th ed. *Saunders, An Imprint of Elsevier,*

zalo nhóm duy nhất 0528112107

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày chẩn đoán xác định và nguyên tắc điều trị của hội chứng chảy máu trong ổ bụng?

Câu 2. Hãy trình bày chẩn đoán xác định và nguyên tắc điều trị hội chứng viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng?

zalo nhóm duy nhất 0528112107